

«Гіпертрофічна кардіоміопатія»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- продемонструвати комунікативні навички (*привітатися з пацієнтом; назвати себе; запитати, як звертатися до нього; запропонувати зручно сісти; забезпечити під час бесіди ізоляцію від впливу різних подразників (сторонні розмови, телефонні дзвінки, тощо); сісти поруч за стіл*).
- спитати скарги та деталізувати їх;
- в'яснити анамнез захворювання та життя;
- продемонструвати практичну навичку “Аускультация серця”;
- виділити провідний синдром;
- провести розмову з пацієнтом щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя;
- продемонструвати невербальні компоненти ведення бесіди (тактовність, ввічливий тон, вираження емпатії тощо).

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

- Сценарій «Збір скарг та анамнезу, об’єктивне обстеження хворого з діагнозом гіпертрофічна кардіоміопатія».
- Додаток 1. Об’єктивне обстеження.

Стан середньої тяжкості. Підшкірно-жирова клітковина розвинута надмірно. Шкіра блідо-рожева, чиста, суха. Пастозність стоп і гомілок. У легенях – везикулярне дихання. ЧСС=Пульс=82 за хв., АТ_{на обох руках} 130/90 мм рт.ст. Живіт м’який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви лікар терапевтичного відділення. До Вас звернулася жінка.

Алгоритм дій здобувача.

	Дії здобувача освіти	Текст стандартизованого пацієнта
1.ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ.		
<i>Привітатися з пацієнтом</i>	Доброго дня.	Доброго дня.
<i>Представитися, позначити свою роль</i>	Я лікар-терапевт, Володимир Іванович. Я з Вами поспілкуюсь, огляну, проведу обстеження.	Дуже приємно
<i>Запитати пацієнтку, як</i>	Як я можу до Вас звертатися?	Ольга Володимирівна

<i>до неї можна звертатися</i>		
<i>Уточнити вік пацієнтки</i>	Скільки Вам років?	56 років
<i>Уточнити заняттєву активність</i>	Ви працюєте?	Я перукар.
2.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
<i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i>	Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?	Так
3.ЗБІР СКАРГ ТА АНАМНЕЗУ		
<i>Запитати скарги пацієнтки</i>	Ольго Володимирівно, що Вас турбує?	Біль за грудиною
	Можете розповісти про характер болю, коли він виникає, скільки продовжується, після чого проходить?	Так, звісно. Це стискаючий біль за грудиною, що виникає при ходьбі.
	Вас турбує задишка?	Так
	Вам важко вдихнути чи видихнути?	Я відчуваю нестачу повітря.
	Перебої в роботі серця не відчуваєте?	Дуже часто відчуваю серцебиття і відчуття, начебто серце зупиняється.
<i>Запитати анамнез захворювання пацієнтки</i>	Як давно Ви хворієте?	5 років
	З чим пов'язуєте?	Можливо з тим , що у мене наступила менопауза.
	Розкажіть будь ласка з чого все почалося?	5 років тому я вперше в житті втратила свідомість, можливо після стресу. Після того почала помічати, що після стресу з'являється запаморочення, іноді біль в серці. Не лікувалась.Останні 3 роки крім болю в серці, турбує задишка, серцебиття.

	Що зараз Вас змусило звернутися до лікаря?	Останній місяць посилився біль, задишка.
<i>Запитати анамнез життя пацієнтки</i>	Чим хворіли протягом життя?	ГРВІ, бронхіт
	Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет ?	Ні
	Операції, травми протягом життя?	Ні
	Алергійні реакції? Непереносимість ліків? Шкідливі звички?	Ні
	Спадковість: хтось хворів захворюваннями серця?	Так, брат помер у молодому віці, йому було 34, грав з друзями у волейбол, раптово впав, помер до приїзду швидкої.. Нам сказали гостра серцева недостатність.
		<i>Стан середньої тяжкості. Підшкірно-жирова клітковина розвинута надмірно. Шкіра блідо-рожева, чиста, суха. Пастозність стоп і гомілок. У легенях – везикулярне дихання. ЧСС=Пульс=82 за хв., АТ на обох руках 130/90 мм рт.ст. Живіт м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.</i>
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Попросити пацієнта зняти одяг</i>	Будь ласка звільніть від одягу верхню половину тулуба, я проведу Вам аускультацию серця	Так, зараз.

ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)		
Обробити акустичну мембрану фонендоскопу розчином антисептика		
Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.		
4. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА Додаткова інформація об'єктивного обстеження пацієнта надається здобувачу у паперовому вигляді.		
<i>Провести аускультацию серця</i>	Пальпаторно визначити місце верхівкового поштовху	
	Аускультация серця в коректній послідовності: - перша точка - над верхівкою серця - друга точка - II міжребер'я справа від груднини - третя точка - II міжребер'я зліва від груднини - четверта точка - біля основи мечоподібного відростка груднини - п'ята точка – 4 міжребер'я зліва від груднини	
	Визначити характеристику серцевих тонів: Тони серця приглушені ритмічні, систолічний шум на аорті.	
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Як Ви себе почуваєте, все добре? Одягайтеся.	Так.
	Ольго Володимирівно, на жаль у Вас є проблеми з серцем, треба подальше дообстеження, встановлення заключного діагнозу і призначення ліків.	

5. ВИДІЛИТИ ПРОВІДНИЙ СИНДРОМ		
	Провідний синдром – синдром хронічний біль за грудиною.	Зрозуміла. Що робити?
6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ		
	Спочатку хочу наголосити на тому, що крім регулярного прийому ліків, треба відкоригувати спосіб життя: заборонено спортивне та екстремальне фізичне навантаження, але все одно виконувати регулярні вправи та ведення здорового способу життя. Відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися дієти.	Дякую, лікарю.
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Ольго Володимирівно, чи Вам все зрозуміло?	Все зрозуміла
	Можливо у Вас є запитання до мене?	Немає
	Якщо Вам все зрозуміло і немає до мене більше питань, я дякую Вам за спілкування. До зустрічі.	Вам дякую лікарю, до зустрічі.